EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 79201
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-19 09:21:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HECTOR HUGO ESPINOZA FAUNDEZ			RUN	: 4.311.805-6
F.Nac	: 02-08-1939	Edad	: 84 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BRASIL 67			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 993397974		
Fecha Ingreso	: 2024-02-18	Fecha Egreso	: 2024-02-19 09:21:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. A41.9-SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Sepsis sin foco
Obs Livedo remoso vs Sx microoclusivo
AP: HTA, Obs HPB

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A41.9-SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedente de HTA tratado con Enalapril y amlodipina; rescatado por ley de urgencias ingresa a clínica Andes con disnea a esfuerzos de 3 días de evolución, acompañado de lesiones eritematosas maculares pruriginosas en tórax y cuello, habiendo consultado previamente a servicio de urgencias HSC con manejo ambulatorio y evolución tórpida.
Clínicamente desaturando hasta 88%, hipotenso 77/47mmhg, ameritando reanimación con fluidos y o2.
Evaluado por Dermatología quien indica estudio inmunológico de piel
Lab PCR 146 PCT 0.3 Creat 1.73 ELP 131/4.74 DD mayor a 4000
TAC TAP Bula Pical izq. Atelectasias lineales bibasales. cardiomegalia. Adenopatias mediastinicas reactivas. Quiste cortical renal derecho de aspecto simple. Prostata de tamaño aumentado. Ligeros cambios edematosos subcutáneos en regiones glúteas.
Es trasladado a HSC el 18/02 donde se toman exámenes de laboratorio control donde únicamente destaca aumento de PCR (146) sin algún otro hallazgo pertinente. Durante estancia hospitalaria en buenas condiciones gnerales, eupneico, afebril, sin lesiones en piel evidentes. En vista de ello, se decide alta médica con seguimiento por HODOM para uso de ATB EV.

INDICACIONES AL ALTA

1. Derivo HODOM
2. ceftriaxona 2gr ev dia (Durante 3 días más)
3. paracetamol 1 gr vo c8hrs sos
4. omeprazol 20mgrs vo dia
5. Prednisona 20mg vo c8h luego disminuir progresivamente
6. Clorfenamina 1 vo cada 8hrs
7. lactulosa 15cc vo cada 24hrs SOS
8. IC Dermatología
9. Seguimiento APS HPB
10. Control SOS

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO